

«Хронічний вірусний гепатит С»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- Продемонструвати навичку «Поверхнева пальпація живота».
- Оцінити клінічний аналіз крові.
- Оцінити біохімічний аналіз крові (показники функції печінки).
- Оцінити імуноферментний аналіз (маркери вірусних гепатитів).
- Встановити попередній діагноз.
- Визначити тактику ведення та лікування.
- Означити рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя.

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції з пакетами додаткових матеріалів:

- Сценарій «Діагностика та подальша тактика ведення і лікування хворого з діагнозом хронічний вірусний гепатит С».

Ви лікар приймального відділення. До Вас звернулася жінка 48 років, безробітна.

Скарги: жовтяниця, тривога, диспепсія, зниження апетиту, втрата ваги.

Анамнез захворювання: протягом півроку турбує тривога, поганий сон. Приблизно через 3 місяці відмітила втрату ваги, погіршення апетиту, нудоту. Тиждень тому з'явилася жовтяниця.

Анамнез життя: в минулому ін'єкційна наркоманка, зловживання алкоголем заперечує.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості. Ріст 160 см, вага 55 кг. Температура тіла 36,8 °С. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Шкіра та склери субіктеричні. У легенях – везикулярне дихання. Частота дихальних рухів 18 за хв. Тони серця приглушені ритмічні. ЧСС=Пulьс=86 за хв., АТ 120/80 мм рт.ст. розміри печінки за методом Курлова 12х9х8 см. Селезінка виступає з під краю реберної дуги на 1 см. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

- Додаток 1. Заключення поверхневої пальпації живота (видається після демонстрації навички)

Живіт м'який, безболісний, ознаки подразнення очеревини негативні, розходження прямих м'язів живота немає..

- Додаток 2. Клінічний аналіз крові.

Показник	Значення	Од	Норма	
			ч	ж
Гемоглобін	110	г/л	130-160	120-140
Еритроцити	3,5	$10^{12}/л$	4,0-5,0	3,7-4,7
Тромбоцити	155	$10^9/л$	180,0-320,0	
Лейкоцити	3,8	$10^9/л$	4,0-9,0	
паличкоядерні	2	%	1-6	
сегментоядерні	45	%	47-72	
еозинофіли	3	%	0,5-5	

базофіли	-	%	0-1
лімфоцити	42	%	19-37
моноцити	8	%	3-11
ШОЕ	8	мм/год	2-10 2-15

- Додаток 3. Біохімічний аналіз крові.

<i>Показник</i>	<i>Значення</i>	<i>Одиниці виміру</i>	<i>Норма</i>
Тимолова проба	6,0	одиниці о.щ.	0 – 4
Білірубін загальний	42	мкмоль/л	8,5 – 20,5
прямий	12	мкмоль/л	0,9 – 4,3
непрямий	30	мкмоль/л	6,4 – 17,1
АлАТ	2,3	мкмоль/ (год×л)	0,1 – 0,68
АсАТ	1,86	мкмоль/ (год×л)	0,1-0,45
Лужна. фосфатаза	2205	Од/л	740 - 2100
Сечовина	7,3	мкмоль/л	2,5 – 6,3
Креатинін	0,087	мкмоль/л	0,044 – 0,110

- Додаток 4 Імуноферментний аналіз (маркери вірусних гепатитів).

<i>Показник</i>	<i>Результат</i>	<i>Норма</i>
Anti HAV IgM	негативний	негативний
HBsAg	негативний	негативний
Anti HBcoreIgM	негативний	негативний
Anti HCV Ig(M+G)	позитивний	негативний

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції.

Ви зібрали скарги, анамнез захворювання та життя, провели об'єктивне обстеження:

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>	Форма представлення
1.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
	інформовану згоду отримано;	Сказати
	обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.	Виконати
2.ВИКОНАННЯ НАВИЧКИ «ПОВЕРХНЕВА ПАЛЬПАЦІЯ ЖИВОТА»:		
	Коректне проведення поверхневої орієнтовної пальпації (лікар свою долоню кладе пласко на живіт пацієнта і проводить легкі, обережні натискання м'якушем нігтьових фаланг пальців, переміщуючи на 3-4 см в боки послідовно (проти часової	Виконати

	стрілки): ліва здухвинна ділянка, ліва бокова ділянка, ліве підребер'я, епігастральна ділянка, праве підребер'я, права бокова ділянка, права здухвинна ділянка, навколопупкова ділянка, надлобкова ділянка	
	Дослідження білої лінії живота (просять пацієнта, який перебуває в горизонтальному положенні, підняти голову, відірвавши її від подушки без допомоги рук, а лікар у цей час проводить своїм вказівним пальцем по середній лінії живота нижче мечоподібного відростка)	
	Оцінка напруження, резистентності, болючості передньої черевної стінки, розходження прямих м'язів живота. Наявність вільної рідини.	Сказати (видати здобувачу освіти додаток 1 в паперовому вигляді)
	Самопочуття пацієнта задовільне	Сказати
3. ДІАГНОСТИКА:		
Оцінити клінічний аналіз крові. (Додаток 2)	Лімфоцитоз - ознаки вірусної інфекції. Анемія, лейкопенія- ознаки гіперспленізму тромбоцитопенія -ознаки гіперспленізму та дисфункції печінки.	Сказати/записати в історію хвороби
Оцінити біохімічний аналіз крові (показники функції печінки). (Додаток 3)	Мезенхимально-запальний та Цитолітичний синдроми. Печінкова гіпербілірубінемія свідчать про наявність гепатиту.	Сказати/записати в історію хвороби
Оцінити імуноферментний аналіз (маркери вірусних гепатитів). (Додаток 4)	Наявність антитіл до вірусу гепатиту С свідчить про HCV-інфекцію.	Сказати/записати в історію хвороби
<i>Встановити попередній діагноз:</i>	Хронічний гепатит С	Сказати/записати в історію хвороби
4.ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ		
	Госпіталізація для подальшого обстеження та підбору оптимальної терапії. Призначення дієти із виключенням	Сказати/записати в історію хвороби

<i>Призначено наступні ліки:</i>	алкоголю, жирної та гострої їжі, харчування малими порціями 4-6 разів на добу, теплою їжею Призначення комбінації протівірусних препаратів прямої дії терміном на 12 тижнів Призначення сорбентів Призначення спазмолітиків	
5. Профілактика та пропаганда здорового способу життя:		
	Збалансована дієта. Не вживати алкоголь, не палити. Регулярні помірні фізичні вправи.	Сказати/записати в історію хвороби